

06 - 06- L'Accès Psychotique Aigu - Pr. ADALI

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver pour traiter ce cours sur l'accès psychotique aigu. Les objectifs de ce cours sont définir un accès psychotique aigu en décrire les symptômes reconnaître l'intérêt des examens cliniques et paracliniques lors d'un accès psychotique aigu énumérer les caractéristiques suggérant l'éthiologie organique énumérer les facteurs pronostiques d'un accès psychotique aigu et en expliquer les principes de traitement. L'accès psychotique aigu est anciennement appelé bouffée délirante aigu Dans la CIM-10, il est appelé trouble psychotique aigu et transitoire.

Dans le DSM-5, deux diagnostics peuvent correspondre trouble psychotique bref et trouble schizophréniforme. Devant un accès psychotique aigu, il faut impérativement éliminer une cause organique. Il s'agit en fait d'une urgence psychiatrique.

Il faut rechercher et prévenir le risque suicidaire et des droits aux agressivités. L'évolution de l'accès psychotique aigu est souvent imprédictible. L'accès psychotique aigu est défini comme étant un état psychotique d'installation brutale caractérisé par le polymorphisme des thèmes et des mécanismes délirants par la présence fréquente de troubles de l'humeur et la brièveté de l'épisode.

C'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. L'accès psychotique aigu est une urgence psychiatrique. L'entretien psychiatrique se fait avec l'entourage et le patient s'il est bien sûr accessible.

Il s'agit d'un sujet jeune entre 18 et 25 ans ayant des difficultés affectives et d'adaptation. Il faut chercher à l'amnésie des troubles de la personnalité prémorbite de type histrionique, passive, dépendante, schizoid. Il faut rechercher aussi les antécédents familiaux psychiatriques et la notion de prise de toxiques.

Les facteurs déclenchants sont les facteurs de stress psychosociaux notamment surmenage, épuisement, changement de mode de vie ou de cadre de vie montré à l'université, déménagement, service militaire, un choc affectif, séparation ou à l'occasion d'une incarcération. Le mode de début peut être brutal, quelques jours à un mois avec des programmes dans les jours ou semaines précédant la phase d'état. Le plus souvent ces programmes peuvent passer inaperçus.

Sentiment de suspicion, inquiétude imprécise, misérie comportementale, perception des choses modifiées, insomnies, angoisses et autres. Dans la phase d'état, l'entourage ne reconnaît plus le patient. Le patient présente un syndrome délirant à thématiques riches et multiples persécution, influence, possession, mystique, erotomaniaque et un mécanisme polymorphe, surtout hallucinatoire.

D'autres mécanismes peuvent être retrouvés, notamment l'interprétation, l'intuition et autres. Il

s'agit d'un délire non systématisé avec une participation émotionnelle à tonalités anxieuses, angoisses psychotiques ou une exaltation émotionnelle. Le patient peut présenter aussi un syndrome de dépersonnalisation ou de réalisation où il a l'impression de vivre dans un rêve.

Une fluctuation timide entre exaltation maniaque, accès à effets dépressifs et dysphorie. Il peut présenter aussi une altération des fonctions cognitives, troubles de l'attention, de la concentration, du jugement, absence du syndrome, confusionnel. Les troubles du comportement sont un type d'excitation, agitation, de stupeur catatonique, fugue, voyage pathologique, hétéroagressivité, bagarre, actes médico-légaux ou auto-agressivité avec conduite suicidaire.

D'autres symptômes peuvent être notés, notamment la dissociation psychique. Il s'agit là d'un facteur de mauvais pronostic. L'examen physique est souvent normal.

Cependant on peut noter des signes de déshydratation, de dénutrition et de constipation. L'évolution à court terme se fait par vagues délirantes, c'est-à-dire une fluctuation de l'intensité et du contenu du délire. Des examens paracliniques sont demandés, notamment un bilan de redentissement physique et des examens complémentaires indispensables sont la TDM cérébrale et la recherche de toxiques.

Le bilan est orienté en fonction de l'éthiologie suspectée. Dans cette diapositive, vous retrouverez les critères DSM-5 du trouble psychotique bref. Devant une personne qui présente un syndrome délirant aigu sans antécédent psychiatrique, il faut penser tout d'abord à une cause organique.

Quels sont les caractéristiques qui suggèrent l'éthiologie organique ? D'abord les caractéristiques cliniques atypiques, l'âge de début tardif, plus de 40 ans, l'absence d'antécédents personnels ou familiaux de maladies psychiatriques et les hallucinations surtout visuelles et illusions. Nous devons suspecter une origine organique, l'amélioration des symptômes psychiatriques par le traitement de l'affection organique, la sévérité des troubles cognitifs, la mauvaise réponse au traitement neuroleptique, voire l'aggravation des symptômes après l'introduction d'un neuroleptique. Les causes organiques suspectées sont infectieuses, endocriniennes, métaboliques ou neurologiques.

Les causes toxiques de l'accès psychotique aigu sont soit l'intoxication aiguë aux substances psychoactives, soit le sevrage des substances psychoactives, soit des causes iatrogènes. Ce tableau illustre les diagnostics différentiels organiques de l'accès psychotique aigu. Les diagnostics différentiels psychiatriques de l'accès psychotique aigu sont l'accès maniaque, la mélancolie, les états mixtes, syndrome confusionnel et la poussée processuelle d'une schizophrénie.

L'évolution de l'accès psychotique aigu et la guérison complète en quelques jours à quelques semaines, il est impossible de prévoir l'évolution à moyen ou à long terme. Selon les études, l'évolution à long terme se fait vers la guérison totale sans récurrence dans 50% des cas, la récurrence

avec intervalle libre dans 25% des cas et la chronicité dans 25% des cas. Les facteurs de bon pronostic de l'accès psychotique aigu sont le début brutal, l'absence d'antécédents personnels ou familiaux psychiatriques, l'absence de troubles de la personnalité pré-morbide, l'existence de facteurs déclenchants, le délit riche, le court délai avant le traitement, la bonne réponse au traitement neuroleptique et le niveau socio-économique élevé.

L'accès psychotique aigu est une urgence thérapeutique. L'hospitalisation permet la réalisation d'un bilan étiologique, le dépistage des comorbidités de complications somatiques, des hydratations et des nutriments, la correction des désordres hydroélectrolytiques et métaboliques si besoin et constitue une atmosphère sécurisante, calme, permettant une alliance thérapeutique. Les anxiolytiques psychotiques atypiques sont prescrits en première attention.

Il faut privilégier les formes orales ou formes injectables. Les formes injectables sont indiquées si refus du traitement. Les anxiolytiques psychotiques sont avisées antidépressives, surtout à dose minimale efficace.

Les neuroleptiques sédatifs ou benzodiazépines sont prescrits pour calmer l'agitation et améliorer le sommeil. La contention est à éviter au maximum, sinon la limiter dans le temps. La psychothérapie de soutien est indiquée dès le début d'amélioration des symptômes psychiatriques.

Les axes de surveillance des patients sont le risque suicidaire, les complications somatiques et l'amélioration des symptômes. En plus des effets secondaires des neuroleptiques. Le traitement à moyen et à long terme a pour but la prévention des rechutes.

Lors d'un premier épisode, il faut maintenir le traitement antipsychotique pendant 1 à 2 ans. Lors de la récurrence de l'accès psychotique aigu, maintenir le traitement antipsychotique pendant 2 à 5 ans. La psychoéducation a une place importante dans la prise en charge par la formation systématique du patient et de sa famille à propos des symptômes, des facteurs étiologiques, du traitement et de l'évolution de la maladie.

En conclusion, le premier accès psychotique aigu est un défi pour le diagnostic différentiel et le traitement. Je vous remercie.